

Tromboembolismo pulmonar · abordagem

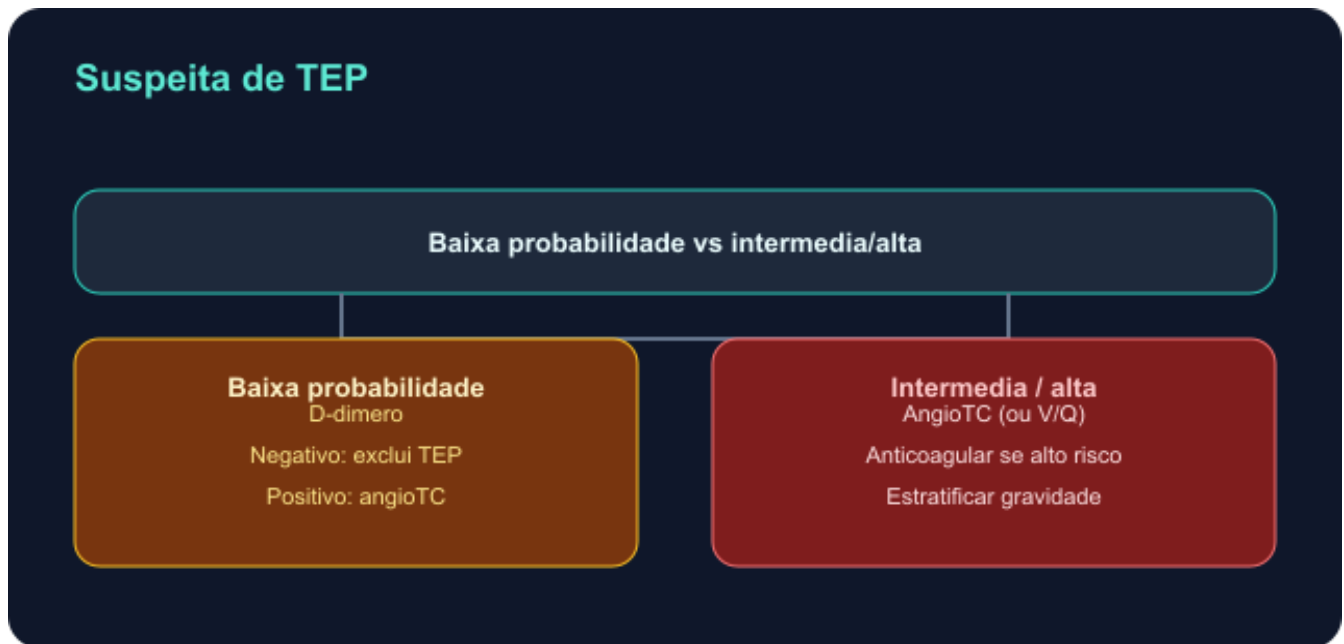
TEP exige estratificar probabilidade pré-teste (Wells/Geneva), usar D-dímero para exclusão em baixa probabilidade e angioTC quando a suspeita for intermediária/alta.

Sinais de gravidade

Lembre - Sinais de gravidade

Hipotensão/choque = TEP de alto risco !' suporte + anticoagulação e considerar trombólise sistêmica.
Disfunção de VD / troponina! / BNP! = risco intermediário — monitorar de perto.

Ramificação de prova: baixa !' D-dímero; intermediária/alta !' imagem sem atrasar anticoagulação se alto risco.



Conduta terapêutica

- Anticoagulação: heparina (HNF/HBPM) ou DOAC conforme cenário e estabilidade
- Trombólise: choque/PCR por TEP sem contraindicação absoluta
- TVP concomitante: USG de MMII ajuda se angioTC indisponível e alta suspeita
- Filtro de VCI: raro — falha/contraindicação formal à anticoagulação

Exames por cenário

Ferramenta | Papel

D-dímero | Excluir em baixa probabilidade

AngioTC pulmonar | Método de escolha na maioria

Ecocardiograma | VD / choque — à beira do leito

Gasometria / ECG | Apoio; S1Q3T3 é pouco sensível

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

D-dímero positivo não confirma TEP — só afasta quando negativo em baixa probabilidade. Em alta probabilidade, não 'espere o dímero': vá direto à imagem e trate o risco.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Wells (e YEARS) estratificam probabilidade de TEP e guiam D-dímero vs imagem.

Baixa/intermediária !' D-dímero; alta !' CTPA (ou V/Q) direto.

Wells TEP

Probabilidade clínica

Sinais de TVP	3
TEP mais provável que alternativa	3
FC > 100	1,5
Imobilização/cirurgia (4 sem)	1,5
TEP/TVP previa	1,5
Hemoptise	1
Neoplasia ativa	1

Tradicional: ≤ 4 improvável | > 4 provável; ou 3 estratos 0-1 / 2-6 / ≥ 7

Itens YEARS: sinais de TVP, hemoptise, TEP mais provável. Corte de D-dímero muda com itens.

YEARS (opcional)

Algoritmo simplificado



Estratificação de gravidade TEP

Risco | Marcadores

Alto (maciço) | Choque / hipotensão sustentada

Intermediário | VD disfunção (Eco/CT) $\pm$ troponina/BNP !', sem choque

Baixo | Estável, sem disfunção de VD / biomarcadores

Conduta-chave

- Anticoagulação precoce se alta probabilidade e baixo risco de sangramento
- Trombólise sistêmica: TEP de alto risco (choque) sem contraindicação
- Intermediário: anticoagular; trombólise só se deterioração
- Wells TVP é outro escore (não misturar pontos)

D-dímero

Atencao - D-dímero

Bom para exclusão em baixa/intermediária probabilidade. Positivo não confirma TEP — seguir para imagem.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1